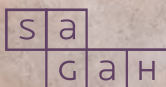


GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS EM SAÚDE

Christiano Braga de Castro Lopes



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Compras com qualidade e valor apropriados

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir compras com qualidade e valores apropriados em serviços de saúde.
- Identificar ferramentas de gestão que auxiliam nas compras com qualidade e com valores apropriados.
- Apontar indicadores de gestão que podem ser utilizados para mensurar compras com qualidade e com valores apropriados.

Introdução

Neste capítulo, você vai poder conhecer a importância do processo de negociação na cadeia de suprimentos e a forma como os métodos e as abordagens podem influenciar no custo total, na qualidade e no valor agregado do serviço. Negociar racionalmente implica não apenas resultados no processo de negociação em si, mas também benefícios em toda a cadeia de suprimentos e no relacionamento entre compradores e fornecedores.

Além disso, você também vai poder entender que a área de compras possui à disposição diversas plataformas e ferramentas que auxiliam os compradores na coleta de dados e informações. Nesse sentido, com a disponibilidade de informações, os compradores passam a formular seus interesses e alternativas para promover a geração de valor nas contratações e aquisições da cadeia de suprimentos. Por fim, você poderá aprender sobre alguns dos mais importantes indicadores da área de compras das instituições de saúde e como eles podem ser vinculados à estratégia, à qualidade e à geração de valor no resultado final.

1 Negociações complexas: racionalidade, qualidade e valor agregado

A negociação é inerente ao ser humano, e todos nós já tivemos a oportunidade de negociar. E por que chamamos a atenção para a forma de negociar? Cavallini e Bisson (2010, p. 102) afirmam que a “[...] negociação, parte fundamental e saudável nos processos de compra, deve ser encaminhada dentro de critérios éticos e vantajosos para o hospital, de maneira clara e com registros devidamente documentados”. Para Bowersox *et al.* (2014, p. 85):

O papel do setor de compras era obter de um fornecedor o recurso desejado pelo menor preço possível. Essa visão tradicional mudou substancialmente nas últimas décadas. O foco moderno encontra-se no custo total e no desenvolvimento de relacionamentos entre compradores e vendedores; como consequência, as compras foram elevadas à categoria de atividade estratégica.

Nesse aspecto, destacamos que, no processo de negociação, assumimos duas posturas distintas, uma mais rápida e intuitiva e outra devagar, mais lógica e deliberativa. Na primeira, agimos por impulso, sem considerar estruturas complexas de negociação; porém, na segunda, apresentamos competências e habilidades que exigem planejamento e conhecimento. Qual a importância disso? A escolha da postura assumida em uma negociação poderá render resultados completamente diferentes, os quais, na área da saúde, podem representar implicações bastante relevantes.

É imprescindível que na negociação haja um processo de comunicação recíproca a fim de se chegar ao melhor acordo para as duas partes, considerando interesses mútuos ou diversos. Considerar o que é justo ou injusto para uma das partes pode ser mais difícil do que parece. Vamos imaginar que, em uma pandemia, itens essenciais para a proteção individual dos profissionais da saúde, como os aventais, as luvas e as máscaras, tenham um relevante aumento de seu custo unitário, tendo em vista a escassez do produto devido ao significativo aumento da demanda. Para você, no cenário apresentado, é justo ou injusto que o custo de uma máscara passe de R\$ 0,24 para R\$ 5,00 a unidade? Porter e Teisberg (2007, p. 305) afirmam que “[...] para possibilitar a competição baseada em valor, todas as práticas de grupos de compras deveriam ser coerentes com a competição justa e aberta”. Porém, isso não é o que ocorre na prática.



Fique atento

Diante de um novo cenário do mercado, um determinado produto pode apresentar uma forte variação de preço. Porém, esse reajuste não deve ser confundido com o superfaturamento, que ocorre quando um produto é adquirido por um valor muito acima da média de preços do mercado. Para entender como se dá o processo de superfaturamento em compras na área da saúde, leia a reportagem “Auditoria aponta superfaturamento na compra de soro fisiológico para pacientes com Covid-19 no RJ”, de Marcelo Bruzzi, publicada no portal de notícias G1.

Portanto, terá vantagem o comprador que detiver informações e conhecimento do mercado e das partes que negociam. Nesse sentido, um grande desafio para os compradores é mitigar o risco de se submeter a ancoragens, isto é, posições iniciais que influenciam todo o processo da negociação. Como comprador, suponha que você não disponha de informações acerca do valor das máscaras e que um determinado fornecedor ofereça R\$ 5,00/unidade. Para você, tentar negociar por R\$ 4,00 parece ser um bom negócio, mas, na verdade, sua proposta se baseou na âncora que foi atribuída pelo fornecedor. Por isso, responder a uma oferta inicial, sugerindo ajustes, dá à âncora uma certa credibilidade.

O grande dilema da negociação é saber que, para se criar valor, é necessário oferecer informações sobre os interesses; por outro lado, revelar esses mesmos interesses pode criar desvantagem e prejudicar a posição na negociação. Então, como agir?

Negociar de forma racional significa tomar a melhor decisão para maximizar os interesses. Ora, perceba que não estamos nos referindo ao “sim”, visto que, em muitos casos, não fazer o acordo pode se apresentar como o melhor negócio. Para Bowersox *et al.* (2014, p. 88):

Embora a prática tradicional de compras possa menosprezar os serviços com valor agregado na busca pelo menor preço possível, executivos de compras eficazes avaliam se esses serviços devem ser realizados internamente, por fornecedores ou se simplesmente não devem ser realizados. A desvinculação de preço permite ao comprador tomar a decisão mais apropriada.

Negociar racionalmente significa chegar ao melhor acordo, e não ficar satisfeito com um acordo qualquer. Estamos falando de qualidade e valor apropriado. É muito importante que você compreenda que a negociação deve ser usada para melhorar o acordo e agregar valor àquilo que está sendo negociado. Analise o posicionamento do Tribunal de Contas da União (TCU) acerca do processo de negociação na administração pública:

Dar ciência (...) de que, no pregão, constitui poder-dever da Administração a tentativa de negociação para reduzir o preço final, conforme previsto no art. 24, § 8º, do Decreto 5.450/2005 (atual art. 38, § 8º, do Decreto 10.024/2019), tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa (BRASIL, 2020, documento *on-line*).

Por que ocorre esse comportamento em processos de licitações? Por que o comprador (representado pelo pregoeiro) se abstém de promover negociações após homologar o menor preço? Na verdade, o que ocorre é que nem sempre os compradores agem de forma racional, prejudicando resultados que trariam valor agregado para a instituição. Acreditar que o melhor valor ou o melhor acordo é o que aparentemente é mais fácil de ser concluído pode se traduzir em incompetência ou falta de compromisso por parte do comprador. Em licitações de medicamentos, por exemplo, é possível perceber diferentes preços homologados para os mesmos medicamentos em regiões geográficas bastante próximas, o que leva a crer que deveriam possuir o mesmo valor de comercialização.

Entre os vieses da negociação, podemos mencionar que um comprador presume que seu ganho deva ser necessariamente superior ao da outra parte, perdendo uma oportunidade de trocas ou concessões benéficas. Para exemplificar, na pandemia do Covid-19, uma medicação bastante procurada no mercado foi a Azitromicina. Suponha que um fornecedor possua 5 mil unidades desse medicamento e deseje vender todo o lote. No entanto, você, como gestor de suprimentos de um determinado hospital, tem interesse em apenas 2 mil unidades, tendo em vista o seu estoque atual. Propor a aquisição de 2 mil unidades dos lotes mais próximos da validade e por um valor abaixo do mercado pode ser uma alternativa que interesse às duas partes. Isso porque, por um lado, o fornecedor ficará com lotes mais novos para vender por um valor atualizado e, por outro, o hospital assegurará uma aquisição estratégica e econômica, visto que esse lote próximo da validade será consumido antes do lote armazenado.

Isso é o que chamamos de **acordo integrativo**. As negociações são mais do que uma simples luta sobre quem fica com a maior parte ou com a parte mais vantajosa. No entanto, os compradores raramente avaliam a relativa importância de seus interesses. As avaliações dos compradores precisam ser baseadas em informações relevantes e não devem ser afetadas pelo modo como as informações são apresentadas, sobretudo nas instituições de saúde, em que, apesar do montante financeiro negociado, boa parte das negociações são influenciadas por aspectos competitivos, em um “ganha ou perde”, também chamado negociação distributiva. As melhores negociações são aquelas concluídas com trocas, nas quais cada parte cede algo — ou desiste de algo — de menor valor em troca de algo de maior valor apropriado.



Saiba mais

Os compradores precisam, acima de tudo, analisar seu processo decisório, considerar o processo da outra parte, avaliar preços reserva, interesses, importância e relevância do que está sendo negociado e, por fim, tentar perceber o processo de negociação como uma oportunidade para agregar valor. No livro “Fundamentos de negociação”, dos autores Roy J. Lewicki, David M. Saunders e Bruce Barry, você poderá aprender sobre estratégias e táticas de negociação, reconhecer a diferença entre negociação integrativa e distributiva, bem como compreender os ajustes e a influência das posições assumidas em uma negociação.

Assim, para atuar em favor da qualidade e do valor apropriado, os compradores precisam identificar a sua área de atuação, os vieses da negociação e reconhecer seus pontos de melhoria, compreender o processo decisório, desenvolver alternativas e estratégias eficazes, saber influenciar positivamente pessoas em ambientes de competição e aperfeiçoar sua capacidade de escuta ativa, visando à compreensão de todo o cenário da negociação.

2 Plataformas e ferramentas como tecnologias de valor agregado

Realizar a programação de compras por meio de um planejamento das necessidades é uma das melhores alternativas para alcançar a qualidade e o valor agregado nas aquisições, visto que recursos financeiros, tempo e demanda são considerados para assegurar a melhor programação possível e eficaz. Programar as compras de uma determinada instituição de saúde pode parecer fácil, mas não é, pois não considerar dados e informações disponíveis pode ocasionar excesso ou falta de materiais nos estoques. Nesse sentido, Ballou (2006, p. 343) afirma que “[...] programar de acordo com as necessidades é uma alternativa para suprir as necessidades a partir dos estoques existentes”.

No entanto, o que ocorre na realidade é que muitas instituições não investem nessa importante função da cadeia de suprimentos, o que acarreta riscos e perdas materiais e financeiras. No Acórdão nº. 1419/2019 - TCU - Plenário, na recomendação do TCU, é possível perceber esse cenário da saúde no País:

Tornar mais eficiente o planejamento de compras dos medicamentos e insumos, assim como sua aquisição e dotação orçamentária, de forma a reduzir o risco de desabastecimento dos estoques de medicamentos e demais insumos de saúde, além de evitar as compras não planejadas e o descarte de produtos vencidos ou inúteis (BRASIL, 2019a, documento *on-line*).

A área de planejamento das necessidades, devido à sua complexidade, exige investimento em tecnologias para que a cadeia de suprimentos seja mais eficiente, desde a coleta de preços para formação de um preço de referência, até a cotação propriamente dita, o processo de compras e o planejamento das necessidades. A pesquisa de preço é uma tarefa essencial na aquisição de materiais médicos e medicamentos, assim como em outras classes de produtos. Chamamos a atenção aos materiais médicos e medicamentos porque, por serem adquiridos em todo o País, podem apresentar variações de preços que, a depender da quantidade a ser adquirida, podem representar ganhos financeiros substanciais.

A formação de um preço de referência, por exemplo, serve de âncora para o valor a ser negociado. Isso porque o preço de referência é o valor que o comprador terá como base para negociar determinado produto, e o método com que ele pesquisa esse preço é estratégico para o processo de compras. Coletar propostas orçamentárias para formar o preço de referência é uma alternativa, assim como pesquisar valores já homologados e adquiridos por outras instituições, como podemos perceber no Acórdão nº 342/2019 - TCU - Plenário:

Determinar às Secretarias Municipais de Saúde de Goiânia, de Pirenópolis e de Petrolina de Goiás, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que façam constar, nos editais licitatórios de aquisições de medicamentos, critérios de aceitabilidade de preços definidos pelos seguintes parâmetros: [...] o Banco de Preços em Saúde, mantido pelo Ministério da Saúde (Acórdão 2.901/2016 - Plenário - Revisor: Min. Benjamim Zymler) (BRASIL, 2019b, documento *on-line*).

No entanto, garantir o melhor preço no momento da aquisição não é suficiente para assegurar a compra de qualidade e maior valor agregado, pois diversas variáveis podem influenciar no registro do preço já acordado entre comprador e fornecedor. A qualidade da compra vai muito além disso, como, por exemplo, garantir que a condição assumida permaneça vantajosa para a instituição durante um contrato de fornecimento.



Exemplo

Plataformas eletrônicas para pesquisa de preços são fundamentais na formação dos preços de referência para a aquisição de materiais médicos e medicamentos. Essas plataformas estão disponíveis no mercado e podem ser utilizadas de forma gratuita, como, por exemplo, o Painel de Preços e o Banco de Preços em Saúde, portais do Governo Federal na internet.

Por isso, é fundamental que, mesmo após a aquisição dos materiais médicos e medicamentos em um determinado processo de compra, os compradores e gestores mantenham a periódica consulta de preços para assegurar a vantagem da condição comercial anteriormente adquirida. Possuir um preço de referência no valor de R\$ 40,00 e adquirir o produto por R\$ 35,00 pode não ser vantajoso depois de alguns meses, e por isso é necessária a aferição dos valores registrados. Isso ocorre porque diversos compradores apenas se concentram na disputa do valor no momento da aquisição, em vez de assegurar sua vantagem no decorrer da contratação. Para Cavallini e Bisson (2010, p. 101), “[...] um comprador eficaz deve manter um arquivo para registrar a ‘vida’ do produto, controlando todas as fases do processo de compra, as variações de preço, as modificações das quantidades solicitadas, as entregas recebidas e o cumprimento das condições acordadas”.

Para tornar a cadeia de suprimentos eficaz, diversas instituições de saúde recorrem a sistemas de informação integrados, também conhecidos como ERPs (*Enterprise Resource Planning*). O ERP, segundo Barbieri e Machline (2017, p. 126), é “[...] constituído por um conjunto de *software* associados às funções da organização e integrados a um banco de dados central, de modo que todas as funções possam usar os mesmos dados”. Se a instituição de saúde busca qualidade em compras, é necessário que as informações estejam instaladas em uma estrutura integrada. Conforme Barbieri e Machline (2017, p. 127),

[...] os mais usados têm origem nacional: o MV Sistemas, desenvolvido em Recife, é dos mais usados; o TASY, também muito empregado, nasceu em Blumenau e foi posteriormente adquirido pela Philips; o TOTVS de saúde, de São Paulo, pertence a uma das maiores empresas de informática do mundo.

O ERP serve de plataforma para outra tecnologia, o MRP (*Material Requirement Planning*).

O MRP atua no planejamento das necessidades de materiais e se apresenta como uma excelente ferramenta para o processo de compras da cadeia de suprimentos. Para Jacobs e Chase (2012, p. 556), o MRP:

[...] fornece a programação que especifica quando cada um desses materiais [...] devem ser encomendados. Existe um registro para cada item gerenciado pelo sistema de MRP. O registro contém dados de necessidades brutas, recebimentos programados, estoque projetado disponível, necessidades líquidas, plano de recebimento de pedido e plano de liberação de pedidos”.

Trata-se de um sistema que analisa as sugestões de compras, baseadas em uma série de informações, como podemos perceber no Quadro 1.

Quadro 1. Sugestão de compra nas plataformas eletrônicas

Código	Descrição	Estoque disponível	Cobertura	Lead time	Consumo médio (3 meses)	Sugestão de compra	Desvio
1641	Acebrofilina 10 mg/mL	2.750	22	11	1.526	1.080	1,86

Como aliadas ao MRP, instituições de saúde com uma estrutura mais robusta na cadeia de suprimentos contam, ainda, com plataformas e ferramentas de *Spend Analysis* (Figura 1). Essa é uma tecnologia de análise do custo unitário da compra, envolvendo dados e informações de controle que interagem para determinar e fornecer ao comprador alternativas para definir e promover a eficiência em compras.

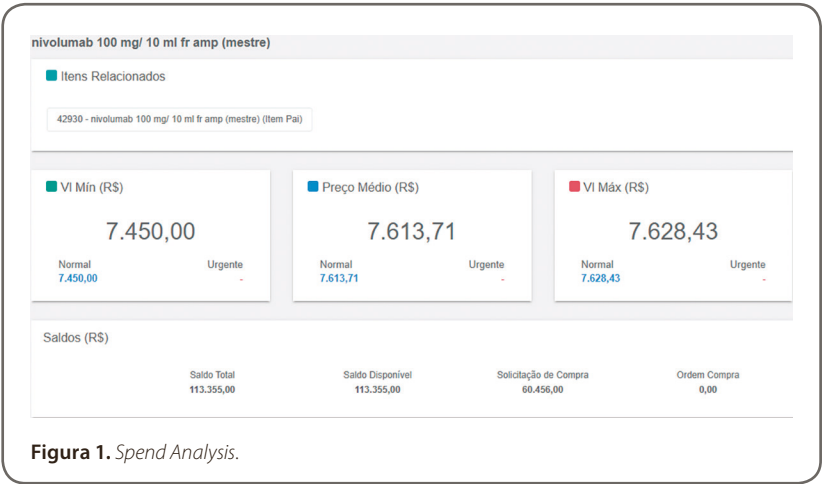


Figura 1. *Spend Analysis*.

Além disso, o *Spend Analysis* avalia a demanda de consumo e a previsão da compra, o valor de compra mensal, a inflação e o histórico da evolução do preço unitário, bem como efetua a comparação de valores mínimo, médio e máximo apresentados por determinado fornecedor. Trata-se de uma tecnologia de alto valor agregado para as instituições de saúde, visto que proporciona uma análise estratégica das aquisições realizadas pela cadeia de suprimentos. Essas tecnologias, plataformas e ferramentas otimizam a cadeia de suprimentos e auxiliam na mensuração de indicadores de resultados para as instituições de saúde.

3 Indicadores de compras para gerar valor agregado

Como você já pôde ver, mensurar indicadores é importante não apenas na cadeia de suprimentos, mas nos mais variados setores de uma instituição. No entanto, saber quais são os indicadores que podem ser utilizados para gerar valor agregado é uma tarefa que exige compreensão do negócio, de suas estratégias e metas. O maior desafio dos gestores de suprimentos é este: definir indicadores de qualidade e que agreguem valor aos processos de suprimentos e da instituição.

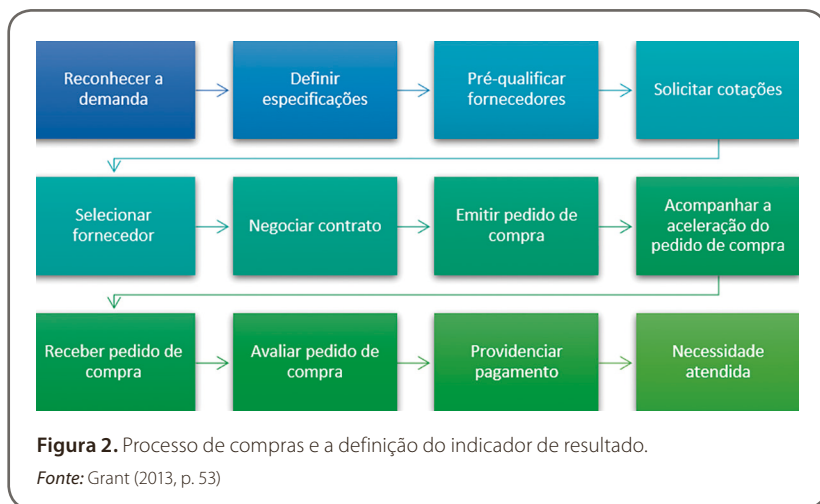
Se considerarmos que, conforme apresentado na Figura 2, o processo de compras inicia no reconhecimento da necessidade e é concluído no pagamento ao fornecedor — e, conseqüentemente, no atendimento a tal necessidade —, toda etapa desse processo poderá ser utilizada como indicador de valor agregado na área de compras de uma instituição de saúde.

É importante compreender que o processo de compra encerra no atendimento da demanda, visto que, se o produto adquirido não satisfizer a demanda solicitada, é o setor de compras que deverá promover o contato com o fornecedor para tentar negociar a devolução, permuta ou outra alternativa para a instituição.

Nesse sentido, e de acordo com o processo de compras estruturado por David B. Grant, Barbieri e Machline (2017, p. 157), são nos apresentados pelos autores alguns indicadores na área de compras, como:

[...] atualização do cadastro de fornecedores, avaliação de fornecedores, seleção de propostas, negociação e ações de diligenciamento realizadas pelo pessoal de compras, com o intuito de assegurar o cumprimento dos acertos feitos com os fornecedores e especificados no pedido de compra.

Assim, se você atua como gestor de suprimentos de uma instituição de saúde cuja meta estratégica é a racionalização dos custos, certamente vai considerar relevante o indicador de negociação com fornecedores. Mas como medi-lo?



Os compradores, em sua grande maioria, definem o vencedor de um processo de compra após a pesquisa e coleta de preços. Normalmente, os departamentos de suprimentos das instituições preconizam que se utilizem pelo menos três ou mais propostas orçamentárias antes de se definir o fornecedor vencedor da cotação. Mas quantos desses compradores, já com a definição da proposta vencedora, buscam uma negociação com o fornecedor visando a otimizar mais ganhos? Se a sua resposta foi “poucos”, você acertou. São raros os compradores que buscam essa negociação, ou melhor, são raros os gestores que definem essa prática como indicador. Tente imaginar uma clínica de saúde de pequeno porte que possua uma compra anual de insumos no valor aproximado de R\$ 1 milhão. Ora, implementar uma meta de negociação de 10% em cada processo renderá para a clínica R\$ 100 mil de *saving*, isto é, o valor que, a partir da melhor proposta apresentada, é “salvo” pelo comprador em uma negociação. O *saving*, além de ser um indicador, é um compromisso pela economicidade e vantajosidade para a instituição que o comprador representa. Ele pode ser mensurado por meio da equação:

$$Saving = \frac{\text{Total do valor negociado}}{\text{Total de compras no período}} \times 100$$

Um outro indicador importante na área de compras é o prazo médio de pagamento (PMP). É comum que o comprador tente negociar o maior prazo possível, com o intuito de dar mais capital de giro para a instituição — e isso é muito importante. Tal indicador pode ser medido por meio da equação:

$$\text{PMPmês} = \frac{\text{Valor total da compra (c)} \times \text{prazo de pagamento (pp)}}{\text{Valor total da compra (c)}}$$

Vale ressaltar que o indicador pode ser medido somente após a conclusão do processo de compra, ou seja, no pagamento ao fornecedor. Analise, no Quadro 2, a adoção desse indicador em uma instituição de saúde que possua quatro processos de aquisição já concluídos.

Quadro 2.

Processo (ordem de compra)	Valor total da compra (c)	Prazo de pagamento (pp) em dias	c x pp
5.246	22.589	29	655.081
5.248	100.874	30	3.026.220
5.251	59.500	25	1.487.500
5.252	82.000	27	2.214.000
[...]	264.963	[...]	7.382.801

Fonte:

$$\text{PMPmês} = \frac{7.382.801}{264.963} = 27,86 \text{ dias}$$

Para Barbieri e Machline (2017, p. 156), é esperado “[...] que esse prazo aumente ao longo do tempo”. Contudo, se estamos falando sobre qualidade e valor agregado, temos que considerar o outro lado da negociação, como você pôde perceber anteriormente.

Assim, quanto menor for o prazo médio de pagamento, mais rápido o fornecedor vai se capitalizar e repor seu estoque, promovendo o reabastecimento e a distribuição de novos produtos para os hospitais e as demais instituições de saúde, até porque “[...] grande parte da preocupação do setor de compras concentra-se na interface logística entre a organização e sua base de fornecedores” (BOWERSOX *et al.*, 2014, p. 99). Grant (2013, p. 53) nos dá um breve exemplo sobre esse indicador quando afirma que:

[...] em geral o pagamento é feito 30 dias após o recebimento das mercadorias, mas algumas empresas oferecem descontos se a fatura for paga antes do prazo. Por exemplo, um desconto de 2% pode ser concedido se uma fatura for paga dez dias após o recebimento [...].

Perceba o valor agregado da aquisição se o prazo médio de pagamento for adotado como indicador.

É fundamental que a área de compras de uma instituição de saúde adote pelo menos dois indicadores essenciais, quais sejam, o índice de compras de urgência e o nível de serviço. O indicador de urgência pode ser medido pela relação entre o número de aquisições ou de produtos com urgência e o número total de aquisições ou de produtos adquiridos em determinado período. Assim, ele pode ser medido periodicamente por meio da equação

$$\frac{\text{Compras de urgências}}{\text{Total de compras realizadas}} \times 100$$

Essa medida pode ser feita de forma quantitativa ou financeira, do modo que melhor convier ao cenário que a instituição de saúde pretenda avaliar. O indicador do nível de compras de urgência é essencial, visto que ele possui uma relação direta com o planejamento da contratação e aquisição. Para Barbieri e Machline (2017, p. 157), “[...] a necessidade de efetuar compras urgentes decorre de previsões equivocadas, atrasos para aprovar pedidos e outras situações fora do âmbito das compras propriamente dito. Compras urgentes sempre ocorrem, por melhor que seja o planejamento”. De qualquer forma, esse é um assunto bem delicado na área de compras, especialmente no que concerne à falta do planejamento.

A contratação e aquisição de forma emergencial é amparada na administração pública e disposta no inciso IV do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993, documento *on-line*),

[...] quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa.

Entretanto, para que haja esse processo, é essencial que ele não seja caracterizado pela falta de planejamento, conforme se pode observar a seguir:

Dar ciência à [...] de que a contratação direta, por dispensa de licitação, em face de situação de emergência decorrente da falta de planejamento da diretoria da Companhia, [...], afronta o disposto nos arts. 2º e 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 [...] (BRASIL, 2019c, documento *on-line*).

Como você pôde perceber, apesar de a administração pública dar amparo às instituições públicas de saúde para promover contratações e aquisições simplificadas para a aquisição de medicamentos e materiais médicos hospitalares com urgência, elas não podem ser justificadas pela ausência do planejamento da contratação e aquisição.



Saiba mais

Foram encontradas evidências de superfaturamento proveniente de compras em caráter emergencial no Maranhão, em virtude da pandemia do Covid-19. Para saber mais, leia a notícia “CGU e PF combatem fraudes em compras de máscaras cirúrgicas em São Luís (MA)”, publicada em 9/6/2020, no *site* do Governo Federal.

De qualquer forma, todos os processos de urgência precisam ser justificados por algum critério específico, e “[...] o esperado é que a porcentagem de compras urgentes em relação às compras regulares seja pequena, algo em torno de 5%” (BARBIERI; MACHLINE, 2017, p. 157).

Na área de compras, o outro indicador fundamental como agregador de valor para a qualidade dos serviços específicos da cadeia de suprimentos é o nível de serviço. Esse indicador mede a eficiência do setor de compras e “[...] envolve diversas dimensões relacionadas diretamente com a satisfação dos clientes em relação ao desempenho do sistema logístico na sua totalidade, no qual a contribuição da área de compras é decisiva” (BARBIERI; MACHLINE, 2017, p. 156). Assim, alguns indicadores podem ser utilizados para medir o nível de serviço na cadeia de suprimentos, mais especificamente na área de compras, como, por exemplo, o número de requisições devolvidas (por inconformidade ou erro de pedido pelo demandante) em relação ao número total de requisições recebidas pelo setor de compras, medido pela equação:

$$\frac{\text{Requisições devolvidas}}{\text{Total de requisições}} \times 100$$

o número das requisições atendidas em relação ao total de requisições, medida pela equação

$$\frac{\text{Requisições atendidas}}{\text{Total de solicitações}} \times 100$$

o número de entregas no prazo pelo total de entregas efetuadas, mediante o número de aquisições, podendo ser medida pela equação

$$\frac{\text{Entregas no prazo}}{\text{Total de entrega efetuadas}} \times 100$$

entre outras. Como dito anteriormente, isso dependerá do que a instituição e sua cadeia de suprimentos consideram valor agregado para as metas e os resultados pretendidos.

Neste capítulo, vimos que a área de compras e os compradores podem exercer uma função estratégica na cadeia de suprimentos, não apenas na otimização de suas operações, mas também na promoção da qualidade dos serviços prestados e na geração de valor agregado para as instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas. Entender o processo de forma sistêmica e os resultados a que o negócio se propõe é fundamental para nortear a área de compras na decisão do investimento em plataformas e ferramentas de gestão e no estabelecimento dos indicadores de resultado.



Referências

BALLOU, R. H. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos/Logística empresarial*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BARBIERI, J. C.; MACHLINE, C. *Logística hospitalar: teoria e prática*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

BOWERSOX, D. J. *et al. Gestão logística da cadeia de suprimentos*. Porto Alegre: Bookman, 2014.

BRASIL. Ata nº. 5, de 20 de fevereiro de 2019. *Diário Oficial da União*, Brasília, 20 fev. 2019b. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/67378017. Acesso em: 11 jul. 2020.

BRASIL. Ata nº. 10, de 1º de abril de 2020. *Diário Oficial da União*, Brasília, 1 abr. 2020. Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-10-de-1-de-abril-de-2020-252079727>. Acesso em: 11 jul. 2020.

BRASIL. Ata nº. 10, de 3 de abril de 2019. *Diário Oficial da União*, Brasília, 3 abr. 2019c. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71925460. Acesso em: 11 jul. 2020.

BRASIL. Ata nº. 22, de 19 de junho de 2019. *Diário Oficial da União*, Brasília, 19 jun. 2019a. Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-22-de-19-de-junho-de-2019-180689622>. Acesso em: 11 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 22 jun. 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 11 jul. 2020.

CAVALLINI, M. E.; BISSON, M. P. *Farmácia hospitalar: enfoque em sistema de saúde*. 2. ed. Barueri: Manole, 2010.

GRANT, D. B. *Gestão de logística e de cadeia de suprimentos*. São Paulo: Saraiva, 2013.

JACOBS, F. R.; CHASE, R. B. *Administração de operações e da cadeia de suprimentos*. Porto Alegre: Bookmann, 2012.

PORTER, M. E.; TEISBERG, E. O. *Repensando a saúde: estratégias para melhorar a qualidade e reduzir custos*. Porto Alegre: Bookman, 2007.

Leitura recomendada

LEWICKI, R. J.; SAUNDERS, D. M.; BARRY, B. *Fundamentos de negociação*. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



Fique atento

Os *links* para *sites da web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS